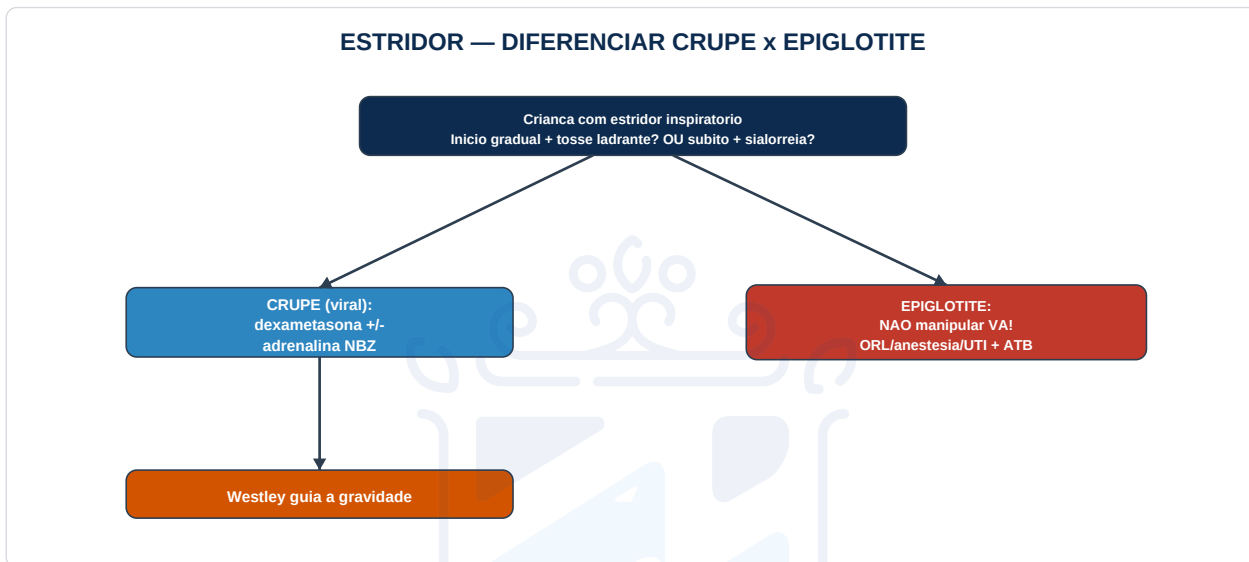


CRUPE x EPIGLOTITE — ESTRIDOR NA CRIANÇA

FLUXOGRAMA — ESTRIDOR + TOSSE



CRUPE x EPIGLOTITE — DIFERENCIAÇÃO

Característica	Crupe (viral)	Epiglotite (emergência)
Agente / idade	Vírus (parainfluenza); 6m-3a	H. influenzae b; 2-7a (raro se Hib em dia)
Início / febre	Gradual (2-3 dias); febre baixa	SÚBITO (<6-12h); febre ALTA (>39)
Tosse	LADRANTE (latido)	Ausente/mínima
Estridor / posição	Inspiratório, piora à noite; qualquer posição	Bifásico grave; posição em TRIPIÉ
Salivação / aspecto	Normal	SIALORREIA; aspecto tóxico

ESCORE DE WESTLEY (gravidade do crupe)

Pontuação	Classificação / conduta
0-2	LEVE — alta domiciliar possível (após dexametasona)
3-7	MODERADO — observação/internação (dexametasona + adrenalina nebulizada)
>= 8	GRAVE — UTI, risco de IOT
Itens	Estridor, tiragem, entrada de ar, cianose, nível de consciência

TRATAMENTO DO CRUPE

Rx DEXAMETASONA EM TODOS + ADRENALINA SE MOD/GRAVE

DEXAMETASONA 0,6 mg/kg (máx 16 mg) VO/IM/EV — dose única, para TODA gravidade (inclusive leve)
Adrenalina NEBULIZADA (crupe moderado/grave com estridor em repouso): L-adrenalina ou adrenalina 1:1000
Observar $\geq$ 2-4h após a nebulização (efeito transitório, risco de rebote)
O2 'blow-by' (próximo ao rosto, sem agitar a criança); manter a criança calma (colo dos pais)
Alta se: leve, sem estridor em repouso, após observação e dexametasona; retorno se piora
Crupe grave refratário a múltiplas doses de adrenalina -> UTI (risco de IOT)

EPIGLOTITE — EMERGÊNCIA DE VIA AÉREA

NÃO MANIPULAR A VIA AÉREA

- NÃO fazer oroscopia/baixar a língua (risco de obstrução total reflexa)!
- NÃO deitar a criança nem agitá-la; manter na posição preferida (tripé), com os pais
- O2 'blow-by'; acionar IMEDIATAMENTE ANESTESIA + ORL + UTI
- IOT em CENTRO CIRÚRGICO com equipe preparada (via aérea difícil); traqueostomia de resgate
- ATB: Ceftriaxona 50-100 mg/kg/dia EV (máx 2g/dose) OU Cefotaxima — APÓS via aérea segura
- Exames (hemograma/hemocultura) e laringoscopia somente após assegurar a via aérea

QUANDO PEDIR EXAMES

IMAGEM (só se estável)

- RX cervical NÃO é obrigatório no crupe típico; considerar se diagnóstico incerto
- Crupe: 'sinal da torre/ponta de lápis' (estreitamento subglótico)
- Epiglotite: 'sinal do polegar/dedo de luva' (epiglote edemaciada)
- NUNCA enviar criança com suspeita de epiglotite sozinha ao RX (risco de obstrução)
- Laboratório: desnecessário no crupe; na epiglotite, após via aérea segura

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ ALTA (crupe): Westley 0-2, sem estridor em repouso, boa entrada de ar, após dexametasona e observação
- ☐ INTERNAR/UTI: crupe grave (Westley $\geq$ 8), refratário à adrenalina, ou SUSPEITA DE EPIGLOTITE
- ☐ Epiglotite: internação em UTI obrigatória, via aérea assegurada em centro cirúrgico
- ☐ Orientar retorno se: piora do estridor, esforço respiratório, sonolência, sialorreia
- ☐ Verificar status vacinal (Hib) — orientar atualização

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Criança ___ anos/___ kg com ___ (crupe grave / suspeita de epiglotite); Westley ___ pontos.
- Estridor ___, tiragem ___, entrada de ar ___, sialorreia ___; vacina Hib: ___.
- Conduta: dexametasona ___, adrenalina NBZ ___ doses (crupe) / NÃO manipular VA + ATB (epiglotite).
- Solicito UTI pediátrica + IOT em centro cirúrgico (epiglotite); preparar material de via aérea no transporte.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Criança de 5 anos com início súbito de febre alta, sialorreia, posição em tripé e ausência de tosse. Conduta?

- A) Oroscopia imediata para visualizar a orofaringe
- B) NÃO manipular a via aérea; manter calma, O2 blow-by, acionar anestesia/ORL/UTI e antibiótico após via aérea segura (epiglotite)
- C) Dexametasona oral e alta
- D) Adrenalina nebulizada e observação domiciliar
- E) Apenas antitérmico

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual medicação está indicada em TODOS os casos de crupe, independentemente da gravidade?

- A) Antibiótico
- B) Dexametasona (0,6 mg/kg, dose única)
- C) Adrenalina nebulizada em todos
- D) Anti-histamínico
- E) Salbutamol

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual achado clínico melhor diferencia o crupe da epiglotite?

- A) Presença de febre
- B) Tosse ladrante com início gradual (crupe) vs início súbito com sialorreia e sem tosse (epiglotite)
- C) Idade da criança apenas
- D) Presença de coriza
- E) Cor da pele

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

No crupe moderado a grave com estridor em repouso, qual conduta acrescenta-se à dexametasona?

- A) Antibiótico endovenoso
- B) Adrenalina nebulizada (com observação por algumas horas)
- C) Oroscopia
- D) Anti-histamínico
- E) Broncodilatador beta-2

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual é o sinal radiológico clássico da epiglotite?

- A) Sinal da torre (estreitamento subglótico)
- B) Sinal do polegar/dedo de luva (epiglote edemaciada)
- C) Sinal do duplo halo
- D) Sinal da bandeira
- E) Sinal de Westermarck

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Início súbito + febre alta + sialorreia + posição em tripé sem tosse = epiglotite. NÃO se manipula a via aérea (oroscopia pode causar obstrução): manter a criança calma, O2, acionar anestesia/ORL/UTI e antibiótico após a via aérea estar segura.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A dexametasona 0,6 mg/kg em dose única está indicada em TODOS os crupes (leve a grave), reduzindo o edema subglótico e a necessidade de retorno/internação.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O crupe tem início gradual com tosse ladrante e febre baixa; a epiglotite tem início súbito, febre alta, sialorreia, posição em tripé e ausência de tosse — esta última é emergência de via aérea.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

No crupe moderado/grave com estridor em repouso, acrescenta-se adrenalina nebulizada à dexametasona, mantendo a criança em observação por algumas horas pelo risco de efeito rebote.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A epiglotite mostra o 'sinal do polegar/dedo de luva' (epiglote edemaciada) no RX cervical em perfil; o crupe mostra o 'sinal da torre' (estreitamento subglótico) no AP. Imagem só se a criança estiver estável.

SM24
Suporte ao Plantão Médico